PACIENTE
Roberto Carlos Cartes Jiménez

Datos de demostración
Grupo sanguíneo O+ · Ficha DEMO-NEURO-2025-0311-01

INFORME NEUROLÓGICO

Cefalea tensional episódica

Evaluación clínica inicial y plan de seguimiento.

Fecha: 11-03-2025 · Dr. Ignacio Pérez · Hospital de Referencia (ejemplo)

Motivo de consulta

Cefalea episódica de seis meses de evolución, holocraneana, opresiva, de intensidad leve a moderada, sin náuseas ni fotofobia marcada. Relacionada con semanas de mayor carga laboral.

Antecedentes relevantes

- Sin migraña previa diagnosticada ni antecedentes familiares de epilepsia.
- Sueño irregular en períodos de mayor demanda.
- Sin uso excesivo de analgésicos.

Hallazgos

- Examen neurológico completo normal: pares craneales, fuerza, sensibilidad y reflejos.
- Sin rigidez de nuca ni signos meníngeos.
- Fondo de ojo sin edema papilar.
- Escala de impacto de cefalea leve; sin criterios de cefalea secundaria.

Diagnóstico e impresión clínica

Diagnóstico de ejemplo
Cefalea tensional episódica, sin signos de alarma. Se solicita electroencefalograma para completar estudio y se refuerzan medidas de sueño e higiene.

CÓDIGO CIE-10	G44.2	ESPECIALIDAD	Neurología

Plan y recomendaciones

- Pauta de sueño regular de 7 a 8 horas e hidratación adecuada.
- Pausas activas y ejercicios de cuello durante la jornada.
- Ejercicio aeróbico regular; evitar ayunos prolongados.
- Electroencefalograma y control en 6 semanas.
- Analgésicos solo de forma ocasional; evitar uso frecuente.

Signos de alarma
Cefalea súbita de máxima intensidad, fiebre con rigidez de nuca, déficit neurológico focal, alteración de conciencia o cefalea que despierta por la noche.

DOCUMENTO DE EJEMPLO

Dr. Ignacio Pérez
Neurología · documento de ejemplo
Documento de ejemplo

SIN VALOR CLÍNICO